PLEXO | Guía de uso y evaluación para OSTEL

Demo: https://cauce-web-production.up.railway.app/ **Edición:** octubre de 2026.

Esta guía acompaña al equipo de OSTEL en el uso de PLEXO: desde la gestión de afiliados y autorizaciones hasta su relación con distintos prestadores. El recorrido les permitirá probar las herramientas y registrar los ajustes que necesitan para su operación habitual. Todos los prestadores, personas, documentos, planes, importes y condiciones de los ejemplos son ficticios. **El escenario no representa acuerdos, cartilla ni condiciones reales de OSTEL.** No carguen información real de afiliados en este ejercicio.

1. Qué van a encontrar

OSTEL tiene un padrón único y convenios separados con tres instituciones. La red permite mostrar que una obra social trabaja con distintos prestadores, sin convertirse ella misma en un hospital ni mezclar las historias clínicas.

Prestador ficticio	Operación preparada	Acuerdo ilustrativo con OSTEL
Sanatorio del Parque · Demo OSTEL	Consultas, radiografías, internación, farmacia y finanzas	Consulta $28.000; radiografía $45.000; respuesta de autorización en 48 horas
Centro Ambulatorio del Sur · Demo OSTEL	Consultas, turnos, farmacia de apoyo, derivaciones y finanzas	Consulta $22.000; convenio independiente
Diagnóstico Norte · Demo OSTEL	Radiografías, turnos, insumos y finanzas	Radiografía $38.000; respuesta de autorización en 72 horas

Hay dos planes de ejemplo. Base cubre 80% de consultas, con hasta 6 al año, y 70% de radiografías, con hasta 2 al año. Plus cubre 100% de consultas, con hasta 12 al año, y 90% de radiografías, con hasta 4 al año. Las radiografías requieren autorización previa. Los límites corresponden al año calendario.

Lo que conviene comprobar: el mismo afiliado puede atenderse en dos instituciones con aranceles diferentes. El consumo de su cupo se acumula entre los prestadores. Cambiar de institución no lo reinicia.

2. Cómo entrar y elegir el contexto

Las contraseñas se entregan por un canal separado. No están en esta guía. Si un acceso falla, soliciten al responsable de la demo verificar su usuario y la contraseña vigente.

Acceso	Usuario	Para qué sirve
Evaluación completa	consultora@ostel.demo.test	Cambiar entre OSTEL y las tres instituciones ficticias; recorrer configuración y operación

Acceso	Usuario	Para qué sirve
Administración de OSTEL	admin@ostel.demo.test	Planes, padrón, convenios, usuarios y datos protegidos habilitados
Autorizaciones	autorizaciones@ostel.demo.test	Responder solicitudes; sin acceso habilitado a salud o cobranza del padrón
Salud del padrón	salud@ostel.demo.test	Revisar datos de salud declarados del padrón con permiso específico
Cobranza del padrón	cobranza@ostel.demo.test	Revisar la situación de cobranza informada con permiso específico
Auditoría de OSTEL	auditor@ostel.demo.test	Consultar y contrastar la vista de sólo lectura
Portal del paciente	paciente@ostel.demo.test	Entrar desde el acceso de pacientes; consultar turnos y registros propios de Martín Pereyra

Para cada institución también hay personal propio:

Institución	Administración	Profesional	Enfermería
Sanatorio	adm@sanatorio.ostel.demo.test	medico@sanatorio.ostel.demo.test	enfermeria@sanatorio.ostel.demo.test
Ambulatorio	adm@ambulatorio.ostel.demo.test	medico@ambulatorio.ostel.demo.test	enfermeria@ambulatorio.ostel.demo.test
Diagnóstico	adm@diagnostico.ostel.demo.test	medico@diagnostico.ostel.demo.test	enfermeria@diagnostico.ostel.demo.test

Usen el selector de organización para elegir OSTEL o el prestador sobre el que van a trabajar. Para comparar dos perfiles simultáneos, usen perfiles de navegador separados o una ventana privada: las pestañas normales comparten sesión.

El acceso de evaluación concentra permisos para facilitar el recorrido, sólo en el escenario ficticio. No representa los permisos que debería tener cada persona en una implantación real. Usen los perfiles específicos para evaluar la separación de responsabilidades. Los datos históricos de la demo siguen existiendo; estos accesos no reciben acceso global a otras organizaciones.

3. Primer recorrido: del afiliado a dos prestadores

1. Ingresen como **consultora**, elijan **OSTEL · Demostración** y abran el padrón.
2. Busquen a **Martín Pereyra**, número **OSTEL-D001-00**. Revisen su plan Base, sus datos administrativos y los integrantes de su familia.
3. Consulten su actividad: tiene una consulta realizada en el Sanatorio y otra en el Centro Ambulatorio. Comparen prestador, prestación e importe propio.

4. Cambien al **Sanatorio del Parque**, abran Pacientes y busquen a Martín. Revisen la atención firmada de esa institución.
5. Cambien al **Centro Ambulatorio del Sur** y repitan. Hay otra ficha institucional y otra atención; no una historia clínica completa compartida.
6. Desde una atención nueva de consulta, seleccionen su afiliación y evalúen cobertura. En el ejemplo inicial quedan **4 de las 6 consultas anuales**: ya usó una en cada institución. Consultar no reserva cupo.
7. Comparen los aranceles: $28.000 y $22.000. Con el plan Base, el 80% corresponde al financiador y el 20% al paciente. Registrar la distribución no significa cobrar.

Resultado esperado: una afiliación estable, dos prestadores, dos aranceles y un cupo compartido. Si antes completaron nuevas atenciones o reservas, la disponibilidad ya puede ser menor: ese cambio es parte del ejercicio.

4. Padrón, familias, legajo e importaciones

Con **admin@ostel.demo.test**, abran el padrón de OSTEL. Hay **24 afiliados**, organizados en seis grupos familiares: Pereyra, Benítez, Sosa, Acosta, Vega y Medina. Cada grupo incluye titular, cónyuge, menor e hijo estudiante.

- Abran **Julián Pereyra**: su trámite está en revisión y tiene una presentación

de estudios pendiente de verificar. Registrar una presentación no adjunta un archivo.

- Revisen un afiliado con trámite completo: tiene documentación verificada y

credencial externa informada. Esto no implica emisión oficial de credenciales.

- Prueben filtros, búsqueda, ordenamiento y exportación del padrón. Comparen

el resultado exportado con los filtros aplicados.

- Para importar, descarguen una plantilla desde esta misma demo, completen

una muestra ficticia y revisen la previsualización antes de confirmar. La importación incorpora o actualiza filas; omitir una persona no le da de baja.

- Comparen **salud**, **cobranza** y **autorizaciones**: los permisos sobre

datos protegidos se otorgan por separado.

Ejemplos para conversar: Martín Vega tiene una declaración ficticia de salud. Martín Medina tiene una baja administrativa informada y continuidad prestacional declarada. Su situación de cobranza indica deuda informada. Ninguna de estas declaraciones constituye por sí sola un corte automático de cobertura ni una cuenta corriente calculada.

5. Autorizaciones: trabajo de ambos lados

En OSTEL, entren como **autorizaciones** y abran las solicitudes. Hay ejemplos de Sanatorio del Parque y Diagnóstico Norte para estas personas de la familia Benítez:

Persona	Situación inicial	Ejercicio
Martín Benítez	Pendiente	Revisar el pedido y aprobarlo o rechazarlo con motivo
Lucía Benítez	Observada	Desde el prestador, completar el respaldo y reenviar
Camila Benítez	Rechazada	Revisar el motivo y el estado conservado del caso
Julián Benítez	Aprobada y utilizada	Consultar la autorización y la prestación realizada

Después de aprobar una solicitud, vuelvan al prestador correspondiente y continúen la atención. No confundan aprobar la autorización con realizar la práctica o registrar su cobro: son hechos distintos.

Las solicitudes vencen según el convenio, a las 48 o 72 horas desde su creación. Si encuentran una solicitud vencida, revisen su historial y creen una nueva desde otro caso para continuar la práctica.

6. Cobertura, copagos y consumos externos

En el prestador, abran **Coberturas y copagos** y luego un caso ambulatorio. Revisen afiliación, cobertura evaluada, importe, aceptación y reservas.

- **Martín Sosa:** tiene seis consultas externas informadas en el año. Al

evaluar una nueva consulta aparece el cupo agotado en ambos prestadores. Es un consumo declarado por la obra social, no una atención clínica inventada dentro de estos hospitales.

- Para otra persona, evalúen una consulta con cobertura parcial; registren la

aceptación del copago antes de realizarla. La reserva compromete cupo y se convierte en consumo al completar la prestación.

- Revisen los cargos y saldos resultantes. Un saldo pendiente requiere la

resolución administrativa correspondiente; no debe interpretarse como cobrado.

7. Turnos, atención, filas e historia clínica

Elijan un prestador con el usuario **consultora** o su personal propio.

1. En **Agenda**, hay disponibilidades de lunes a viernes y turnos futuros. Avancen entre las próximas semanas para ver las citas de cada prestador. Reserven, confirmen o reprogramen un turno de prueba.
2. En **Casos** y **Filas**, seleccionen una atención pendiente y llamen al paciente.
3. Registren una evolución y completen la atención con el profesional de esa institución. La firma requiere una matrícula, ya cargada para los perfiles de prueba.
4. Desde **Pacientes**, consulten los registros que dejó la atención.
5. Revisen el historial del caso y las notificaciones asociadas a la operación.

Cada profesional trabaja con su institución y sus áreas. La cuenta de OSTEL no equivale a un médico del hospital. El acceso del financiador a evoluciones clínicas tiene un alcance propio y exige motivo; no habilita la historia clínica completa de todos los hospitales.

8. Internación y farmacia

En **Sanatorio del Parque**, abran **Internación**. Hay ocho camas: una ocupada con una estadía abierta, cinco libres, una en higiene y una bloqueada por mantenimiento. El paciente internado de ejemplo es **Martín Acosta**.

Revisen su caso y la cama asignada. Pueden probar el circuito de evolución, pase o egreso según las acciones que ofrezca el caso. Una cama en higiene o bloqueada no está disponible para una nueva asignación.

En **Farmacia**, revisen depósitos, stock y lotes de demostración. Hay pedidos pendientes de reposición, un insumo por debajo del mínimo y un consumo imputado al caso del paciente internado. Prueben preparar y entregar un pedido, y consulten la trazabilidad del lote.

El stock de la demo no representa un vademécum ni protocolos farmacológicos de OSTEL. Los centros ambulatorio y de diagnóstico tienen depósitos de apoyo; la internación está concentrada en el sanatorio.

9. Red y derivaciones

En **Centro Ambulatorio del Sur** → **Red**, revisen las solicitudes hacia el Sanatorio. Encontrarán ejemplos solicitado, aceptado y rechazado.

Prueben responder una solicitud desde el Sanatorio y consulten el cambio desde el Centro Ambulatorio. Aceptar genera el caso del destino con su ficha institucional. La cobertura del nuevo caso se elige expresamente: el traslado no traslada automáticamente una decisión económica ni comparte toda la historia.

La red de derivaciones y el convenio con OSTEL son relaciones diferentes: pertenecer a una red no activa un convenio de cobertura.

10. Finanzas y comprobantes

En cada prestador, abran **Finanzas** con su administración o con **consultora**. Revisen los costos por atención, los gastos y **Pagos y cobros** del período de los ejemplos; ajusten el filtro de mes si fuera necesario. Hay un gasto ficticio de insumos por **$150.000**, una obligación por ese monto y un pago parcial aprobado de **$50.000**. El saldo pendiente es **$100.000**.

Las consultas y radiografías realizadas dejan sus registros económicos. Revisen cuánto corresponde al financiador y cuánto al paciente; esos cargos no se consideran cobros hasta registrar el movimiento correspondiente.

En OSTEL, revisen **Facturas**: hay dos comprobantes recibidos por cada prestador. Son registros administrativos ficticios, sin adjuntos ni emisión fiscal. No se vinculan automáticamente a una liquidación ni a los movimientos de dinero del ejemplo.

11. Configuración, control y portal del paciente

- **Estructura y usuarios:** revisen las áreas, grupos y pertenencias de cada

institución. Modifiquen sólo datos ficticios del escenario.

- **Flujos y formularios:** los circuitos ya están publicados. Para experimentar,

creen una nueva versión o un flujo de prueba; eviten alterar el recorrido compartido antes de que otras personas lo completen.

- **Auditoría:** después de consultar una historia clínica, revisen el registro

de acceso dentro del alcance del perfil. Una consulta y una modificación son evidencias diferentes.

- **Portal del paciente:** cierren la sesión institucional y usen el acceso de

pacientes con **paciente@ostel.demo.test**. Martín Pereyra tiene identidad ficticia prevalidada, turnos y estudios de muestra en dos instituciones. Los estudios de ejemplo no incluyen archivos descargables. La identidad del paciente está preparada para que puedan ingresar sin realizar un trámite de validación personal.

Para evaluar intercambios con otros sistemas, identifiquen qué información necesitan enviar o recibir, con quién y en qué momento de su operación.

12. Qué está disponible y qué requiere otro trabajo

El recorrido cubre padrón y familias, legajo, planes, convenios, aranceles, autorizaciones, cobertura y cupos, atención y turnos, registros clínicos, internación, farmacia, traslados, costos, gastos, pagos, cobros y comprobantes administrativos.

Circuitos que requieren un alcance adicional: emisión de comprobantes fiscales, contabilidad general, conciliación bancaria, cálculo de aportes o deuda de afiliación, liquidación integral de prestadores, reintegros completos, SURGE e intercambio real con ARCA, ANSES o SSSalud. Si alguno forma parte de su operación, inclúyanlo en el relevamiento para analizarlo con el equipo de PLEXO.

Las necesidades que identifiquen permitirán acordar alcance, prioridades y resultados esperados para una adaptación a OSTEL.

13. Cómo registrar las necesidades reales

Para cada tarea, anoten el resultado con este formato:

Dato	Qué registrar
Obra social y perfil	Quién realiza la tarea y con qué responsabilidad
Tarea y frecuencia	Qué intenta resolver y cuántas veces lo hace
Ejemplo ficticio	Afiliado, prestador o caso utilizado, sin datos reales
Resultado	Se pudo completar / requiere ajuste / no está disponible
Diferencia con su operación	Campo, regla, permiso, aprobación, archivo o paso faltante
Criterio de aceptación	Qué deberían observar para considerar resuelta la necesidad
Prioridad	Impide operar / importante / mejora deseable

Usen tareas concretas: dar de alta una familia, autorizar una práctica, atender en dos prestadores, revisar un cupo o registrar un pago. Si algo no coincide, anoten organización, pantalla, acción y resultado observado. No incluyan contraseñas ni información real de afiliados.

14. Si cambia algo durante la evaluación

La demo conserva lo que ustedes operan. Autorizar una práctica, consumir cupo, pagar una cuenta o cambiar una contraseña modifica los ejemplos iniciales. **Las pruebas no se reinician automáticamente.**

Si un ejemplo ya fue utilizado, continúen con otro afiliado o creen un caso nuevo. Si necesitan volver a comenzar, coordinen con el responsable de la demo la preparación de nuevos ejemplos.

Al terminar, comparen las tareas completadas y las diferencias registradas con la consultora. Ese relevamiento servirá para acordar la adaptación a la operación real de cada obra social.